Mon Suivi Diabète

INTRODUCTION - CONTACT - ANTÉCÉDENTS

AGIR POUR MON ÉQUILIBRE

Prendre soin de sa santé est **essentiel,** surtout avec un diabète.
Cette pochette a été conçue pour vous aider à suivre facilement vos examens et consultations, et permettre une meilleure **coordination** de votre santé.
Un outil **simple** pour mieux comprendre, prévenir et rester acteur de votre **équilibre.**

CONTACTS

Nom : ..... Date de naissance : .....
Prénom : .....

Adresse : .....
Numero de téléphone : .....
Adresse mail : .....
Contact d'urgence : .....

Médecin traitant: ..... Autres professionnels santé : .....
Infirmier(e) : .....
Médecin spécialiste : .....

INFORMATION GÉNÉRALE

ANTECEDENTS:
- .....
- .....
- .....
- .....

DIABETE:
Type : .....
Année diagnostique : .....

TOXIQUE

Tabac :
☐ OUI ☐ NON ☐ SEVRE(E)
Année du sevrage : .....
Cigarettes par jour : .....

Alcool :
☐ OUI ☐ NON
Nbre de verres par semaine: .....

Autre toxique :
- .....
- .....
- .....

ALLERGIES :
☐ OUI ☐ NON
Si oui, précisez : .....

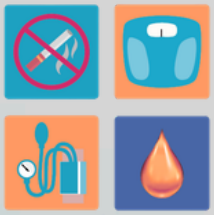
ACTIVITE PHYSIQUE :
☐ OUI ☐ NON
Si oui, précisez : .....
Fréquence / semaine : .....

TRAITEMENTS - ORDONNANCES

QUELS SONT LES OBJECTIFS DU TRAITEMENT ?

→ **Équilibrer** le **taux de sucre** dans le sang.
→ **Prévenir** les complications du diabète (3) (yeux, reins, nerfs, cœur).
→ **Corriger** les facteurs de risque cardiovasculaire.

Et donc améliorer **ma qualité de vie**, et mon espérance de vie.



Le traitement du diabète comporte de multiples aspects:

- Adaptation de l'alimentation,
- Augmentation de l'activité physique.
- Arrêt de la consommation de tabac.
- Suivi régulier et adaptation du traitement.
- Détection des complications naissantes.

TRAITEMENTS MEDICAMENTEUX DU DIABÈTE

TYPE DE TRAITEMENT	COMMENT IL AGIT	CE QU'IL FAUT SAVOIR	EXEMPLES (DCI – nom commercial)
Médicaments par voie orale	Améliorent la sensibilité à l'insuline, réduisent la production de glucose par le foie et/ou augmentent son élimination par les reins.	**Fréquence :** 1 à 2 prises/jour. **Bénéfices** : baisse de la glycémie. **EI** : troubles digestifs, douleur musculaire. **Risques :** hypoglycémie rare (sulfamides). **Surveillance** : tous les 3 mois	Metformine (Glucophage®) Gliclazide (Diamicron®) Sitagliptine (Januvia®) Empagliflozine (Jardiance®) Dapagliflozine (Forxiga®)
Traitements injectables (hors insuline)	Stimulent la sécrétion d'insuline de façon glucose-dépendante, réduisent le glucagon, ralentissent la digestion et augmentent la satiété.	**Fréquence :** injection quotidienne ou hebdomadaire. **Bénéfices** : baisse glycémie, perte de poids. **EI :** nausées transitoires. **Risques :** hypoglycémie très rare. **Surveillance :** tous les 3 mois.	Sémaglutide (Ozempic®) Liraglutide (Victoza®) Dulaglutide (Trulicity®)
Insuline	Apporte une insuline exogène permettant l'entrée du glucose dans les cellules et la baisse de la glycémie.	**Fréquence :** 1 à plusieurs injs/jour **Bénéfices** : contrôle glycémique + **EI :** hypoglycémies, prise de poids. **Surveillance :** quotidienne autosurveillance glycémique/ capteur	Insuline glargine (Lantus® / Toujeo®) Insuline dégludec (Tresiba®) Insuline aspart (Novorapid®)

À RETENIR

Le traitement est à adapter à chaque personne.
Il peut évoluer avec le temps.
L'alimentation et l'activité physique restent indispensables.
Le suivi médical régulier est essentiel;

TRAITEMENTS ET ORDONNANCES

MON TABLEAU DE BORD

SUIVI GLYCÉMIQUE - OBJECTIF HG GLYQUÉE

QUAND – EXAMEN – OBJECTIF DES CONSULTATIONS

À CHAQUE CONSULTATION

- ☑ Mesure du poids et de l'indice de masse corporelle.
- ☑ Discution sur la tolérance du traitement et la prise médicamenteuse.
- ☑ Mesure de la tension artérielle.
- ☑ Recherche des pouls pédieux

TOUS LES 3 MOIS

- ☑ Dosage HbA1c (Hémoglobine glyquée)
  - **Reflet de la glycémie des dernières semaines**
  - Permet **évaluation de l'équilibre du diabète**

AU MOINS 1 FOIS PAR AN

- ☑ Bilan rénal (prise de sang / analyse d'urine)
  - **Dépister des complications rénales (néphropathie)**
- ☑ Bilan lipidique (prise de sang)
  - **Évaluer les risques cardiovasculaires (LDL)**
- ☑ Bilan cardiologique ECG de repos
  - **Dépister une complication cardiaque**
- ☑ Examen du fond d'œil
  - **Dépister une atteinte de la rétine (rétinopathie)**
- ☑ Bilan bucco-dentaire
  - **Dépister des lésions dentaires et gingivales**
- ☑ Examen des pieds
  - **Vérifier l'état et la sensibilité (neuropathie)**

VACCINATION- DEPISTAGE- SUIVI

VACCINATIONS

VACCINS	INDICATIONS / RECOMMANDATIONS	DATE(S) D'INJECTION	CACHET / SIGNATURE
Grippe (VaxigripTetra® / InfluvacTetra®) **COVID-19** (Comirnaty® / Spikevax®)	Rappel annuel ≥ 65 ans ou personnes à risque	___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	
VRS – Virus respiratoire syncytial (Abrysvo® / Arexvy®)	≥ 75 ans ou 65–74 ans avec comorbidités – 1 injection	___ / ___ / ___	
dTcaP (dipathérie, tétanos, polyomélite, coqueluche) – Repevax® / BoostrixTetra®)	25 ans, 45 ans, 65 ans, puis tous les 10 ans	___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	
Zona (Shingrix®)	entre 65–74 ans ou immunodéprimé ≥ 18 ans – 2 doses à 2–6 mois	1re dose : ___ / ___ / ___ 2e dose : ___ / ___ / ___	
Pneumocoque (Prevenar 20®)	≥ 65 ans ou personnes à risque – 1 injection	___ / ___ / ___	
Autres vaccins ---------- ---------- ----------		___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	

DÉPISTAGE POUR LES FEMMES

TYPE	INDICATIONS / RECOMMANDATIONS	DATE(S) RÉALISATION	RESULTAT
CANCER DU SEIN	Mammographie – tous les 2 ans **Femmes de 50 à 74 ans**	___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	---------- ---------- ---------- ----------
CANCER COL DE L'UTERUS	**25–29 ans** : frottis tous les 3 ans **30–65 ans** : test HPV tous les 5 ans	___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	---------- ---------- ---------- ----------

DÉPISTAGE POUR FEMMES ET HOMMES

TYPE	INDICATIONS / RECOMMANDATIONS	DATE(S) RÉALISATION	RESULTAT
CANCER COLO RECTAL	Test immunologique fécal (FIT / Hemoccult®) **Tous les 2 ans** Chez les personnes **asymptomatiques** de **50 à 74 ans** Hors exeption (antécédents personnels/familiaux, MICI, etc.)	___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___ ___ / ___ / ___	

SUIVI DES CONSULTATIONS 1/3

DATE	NOTES MÉDICALES	CACHET / SIGNATURE

SUIVI DES CONSULTATIONS 2/3

DATE	NOTES MÉDICALES	CACHET / SIGNATURE

SUIVI DES CONSULTATIONS 3/3

DATE	NOTES MÉDICALES	CACHET / SIGNATURE

MES FICHES CONSEILS

- ☐ Sevrage tabagique
- ☐ Activité physique
- ☐ Alimentation équilibrée
- ☐ Hypoglycémie
- ☐ Voyage avec le diabète
- ☐ Ramadan et diabète
- ☐ Utilisation
- ☐ INSULINE FIche traitement

Télécharger
MES FICHES CONSEILS en PDF

QUESTIONS - RÉPONSES

Envoyez vos questions
Et obtenez votre réponse sous 48h.
via le site
monsuividiabete.com
Votre médecin vous réponds !

CODE MEDECIN : _ _ _ _ _ _

MES FICHES CONSEILS

MES DOCUMENTS - RDV MÉDICAUX

Rangez vos courrier, résultats biologique etc.
Planifiez vos futurs RDV avec les professionnels de santé.

Mon ESPACE santé :

Retrouvez vos informations de suivi santé; ordonnance numérique sur mon espace santé via le QR CODE

DATE(S)	HEURES	PROFESSIONNEL SANTE	LIEUX
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		
___ / ___ / ___	___ h ___min		

MES RESSOURCES

NOTES PERSONNELLES

Télécharger
MON SUIVI DIABETE
en PDF

SOURCES

1. Site AFD, http://www.afd.asso.fr
2. HAS. Guide parcours de soins - Diabète de type 2 de l'adulte. Mars 2014.
3. HAS. Stratégie médicamenteuse du contrôle glycémique du diabète de type 2. Janvier 2013.
4. Bassuk SS, Manson JE. Epidemiological evidence for the role of physical activity in reducing risk of type 2 diabetes and cardiovascular disease. Appl Physiol (1985). 2005;99(3):1193-204.
5. HAS. Prévention et dépistage du diabète de type 2 et des maladies iées au diabète. Octobre 2014.
6. Hartemann A, et al. Guide pratique du diabète. 5ème édition. Elsevier Masson. 2013.
7. Scheen AJ. Antidiabétiques oraux dans le traitement du diabète de type 2 : perspectives historique et médico-économique. Médecine des Maladies Métaboliques. 2015;9 : 186-97.
8. HAS. L'autosurveillance glycémique dans le diabète de type 2 : une utilisation très ciblée. Avril 2011.
9. Pillon F, et al. Rôle du pharmacien dans la prise en charge du patient diabétique de type 2. Actualités pharmaceutiques. 2014;541:29-34.
10. Guide alimentaire pour tous « la santé vient en mangeant ». Programme national nutrition-santé. Septembre 2002.
11. https://www.ameli.fr/sites/default/files/Documents/Livret%20Rep%C3%A8res_Examens%20de%20suivi%20recommand%C3%A9s_2.pdf